

44-2 금연 상담

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
흡연력에 대해서 자세히 질문하였다.		
금연을 결심하게 된 동기에 대해서 질문하였다.		
흡연을 하게 된 이유 및 유발 인자에 대해서 질문하였다.		
니코틴 의존도(맛이 좋을 때, 아침 담배, 일어나서 몇 분 만에, 하루 얼마나, 금연 구역에서도, 아파도)를 확인하였다(6가지).		
과거 금연을 시도한 경험과 실패 원인에 대해서 질문하였다.		
금단 증상의 유무를 확인하였다(불안, 불면, 짜증, 식욕 증가, 손떨림).		
담배 남용으로 인한 증상을 확인하였다.		
흡연의 단점과 금연의 장점에 대해서 질문하였다.		
금연의 방해 요인을 확인하였다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
동반된 신체 증상에 대해서 질문하였다(기침, 가래, 호흡곤란, 흉통).		
가족력을 확인하였다(호흡기 질환, 암).		
사회력을 확인하였다(술, 담배, 직업).		
환자의 과거 질환 여부를 확인하였다.		

환자 교육	잘함	보통	미흡
현재의 니코틴 의존도에 대해서 설명하였다.			
금연을 해야 하는 동기나 목표를 부각시켰다.			
주변 사람들의 지지와 독려가 필요함을 설명하였다.			
금연 시작 일을 설정하였다.			
금연 전략 방법에 대해서 설명하였다.			

금단 증상에 대해서 설명하고 대처법에 대해서 설명하였다.			
금연 치료제에 대해서 설명하였다(니코틴 보조요법, 경구 복용 약물).			
금연에 성공할 수 있다는 확신을 주었다.			
주기적인 상담을 위해 다음 내원 일을 설정하였다.			
흡연의 단점과 금연의 장점에 대해서 물어보았다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			



Memo